

TEMA 2.13 • GINECOLOGÍA

Proceso Inflamatorio Pélvico (PIP / EIP)

PERFIL EUNACOM 2.01.1.078

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Proceso Inflamatorio Pélvico (PIP / EIP)

Causa

TABLA 2.13.1: ESTADIO VS AGENTES	
ESTADIO	AGENTES
Inicial (endometritis, salpingitis)	Gonorrea (<i>N. gonorrhoeae</i>) + Chlamydia trachomatis
Avanzado (absceso tubo-ovárico, ATO)	Anaerobios (predominan) + Gram negativos

Factor de riesgo principal: Promiscuidad sexual (ETS). También: DIU (recién instalado o retirado).

Clínica — Triada

- **Fiebre**
- **Leucorrea** (flujo purulento por OCE)
- **Dolor pélvico** (el más importante)

Los 3 Dolores Diagnósticos del PIP

TABLA 2.13.2: DOLOR VS DESCRIPCIÓN	
DOLOR	DESCRIPCIÓN
1. Hipogástrico	Dolor a la palpación del útero/hipogastrio
2. Anexial	Dolor a la palpación anexial (examen bimanual)
3. Movilización cervical	Dolor al movilizar el cuello uterino

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Cualquiera de los 3 dolores + fiebre + leucorrea = PIP. Son diagnósticos de causa ginecológica.

Diagnóstico

- **Clínico** (principal). Exámenes de apoyo:
- **Parámetros inflamatorios:** PCR ↑, VHS ↑, leucocitosis
- **Ecografía transvaginal:** buscar **absceso tubo-ovárico (ATO)**

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El ATO en la ETV solo se diagnostica como tal si hay **clínica de PIP** previa. Sin clínica, un tumor anexial en ETV es un tumor ovárico funcional/neoplásico, no un ATO.

Tratamiento

TABLA 2.13.3: SITUACIÓN VS TRATAMIENTO	
SITUACIÓN	TRATAMIENTO
PIP sin ATO, bien tolera vía oral	ATB de amplio espectro VO
PIP sin ATO, peor estado general	ATB de amplio espectro EV
PIP con ATO	ATB EV + drenaje quirúrgico por laparoscopia

Esquema ATB de amplio espectro: - **Ceftriaxona** (cobre gonorrea + Gram negativos) - **Doxiciclina** (cobre Chlamydia) - **Clindamicina** (cobre anaerobios + Gram positivos)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El ATO no drenado → organización → **adherencias tubáricas** → **infertilidad tubo-peritoneal**. El drenaje del ATO es fundamental para preservar la fertilidad.

PIP vs. Apendicitis

- En la mujer, el dolor en FID puede ser PIP o apendicitis. Siempre incluir:
- **βHCG** (descartar embarazo ectópico)
- **Evaluación ginecológica** antes de la apendicectomía

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En la mujer en edad fértil, la apendicitis clínica debe manejarse como una APA: test de embarazo + evaluación ginecológica primero.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Proceso Inflamatorio Pélvico (PIP / EIP), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Proceso Inflamatorio Pélvico (PIP / EIP). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Clínica — Triada
- Los 3 Dolores Diagnósticos del PIP
- Diagnóstico
- Tratamiento
- PIP vs. Apendicitis
- Chlamydia trachomatis
- Factor de riesgo principal:

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PROCESO INFLAMATORIO PÉLVICO (PIP / EIP))**PREGUNTA 1**

Respecto a Proceso Inflamatorio Pélvico (PIP / EIP), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Proceso Inflamatorio Pélvico (PIP / EIP) se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Proceso Inflamatorio Pélvico (PIP / EIP) debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Proceso Inflamatorio Pélvico (PIP / EIP) requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Proceso Inflamatorio Pélvico (PIP / EIP) es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Proceso Inflamatorio Pélvico (PIP / EIP) no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Proceso Inflamatorio Pélvico (PIP / EIP)?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Proceso Inflamatorio Pélvico (PIP / EIP). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: PROCESO INFLAMATORIO PÉLVICO (PIP / EIP)

:::tip Cualquiera de los 3 dolores + fiebre + leucorrea = PIP. Son diagnósticos de causa ginecológica. :::
:::warning El ATO en la ETV solo se diagnostica como tal si hay clínica de PIP previa. Sin clínica, un tumor anexial en ETV es un tumor ovárico funcional/neoplásico, no un ATO. :::
:::warning El ATO no drenado → organización → adherencias tubáricas → infertilidad tubo-peritoneal. El drenaje del ATO es fundamental para preservar la fertilidad. :::